

QCM Chirurgie pédiatrique - VarB 2018

1. *L'atrésie de l'oesophage de type III supposons:
 - A. Les deux segments oesophagiens ne communiquent pas avec la trachée
 - B. Le segment proximal communique avec la trachée et se trouve à moins de 2 cm du segment distale
 - C. Le segment proximal communique avec la trachée et se trouve à plus de 2 cm du segment distale
 - D. Les deux segments oesophagiens communiquent entre eux
 - E. Aucune réponse n'est correcteREP: E
2. *Dans l'omphalocèle le diagnostic prénatal positif se fait par :
 - A. Échographie abdominale après la 13-14ème semaine de grossesse
 - B. Radiographie abdominale en orthostatisme
 - C. CT dans le premier mois de grossesse
 - D. Scintigraphie avec tc99
 - E. Toutes ces réponses sont correctesREP: A
3. *Dans l'hernie hiatale, le diagnostic de certitude est établi par :
 - A. D'après du caractère du vomissement
 - B. Radiographie thoracique de face
 - C. Radiographie thoracique de profil
 - D. Radiographie abdominale sans préparation en orthostatisme
 - E. Examen radiologique répéter en position TrendelenburgREP: E
4. * Dans l'atrésie intestinale de type I se rencontre :
 - A. La continuité de paroi séro-musculaire, avec la lumière bloquée par des septums multiples
 - B. Entre les segments fermés de l'intestin il y a un cordon fibreux, le mésentère est intact ou interrompu en "V"
 - C. Les segments fermés sont complètement séparés, défaut mésentérique en "V"
 - D. Zone atrésiques multiples, complètement séparés, défauts mésentériques en "V" réalise "l'aspect de pagode"
 - E. Aucun des problèmes mentionnésREP: E
5. * Les déclarations suivantes sur la paralysie du nerf facial sont vraies, avec une exception que vous devez indiquer :
 - A. La plus fréquente lésion du système nerveux périphérique
 - B. Ce produit par une compression du nerf par l'épaule du fœtus dans diverses positions viciées intra-utérine
 - C. La conséquence la plus grave est la paralysie de la branche orbitale avec immobilisation de la paupière supérieure
 - D. Le traitement vise la protection de la cornée jusqu'au rétablissement de la fonction nerveuse
 - E. Elle est toujours bilatéraleREP: E
6. *La persistance du canal omphalo-mésentérique signifie :
 - A. Persistance de la portion interne de ductus omphalo-entérique
 - B. Persistance de la portion externe de ductus omphalo-entérique
 - C. Communication perméable entre l'ombilic et l'iléon, par un orifice visible centrale par où s'extériorise un liquide avec contenu intestinale en fonction du calibre du conduit
 - D. Communication perméable entre l'ombilic et la vessie
 - E. Communication imperméable entre l'ombilic et l'iléonREP: C

7. *Dans les fentes du voile palatin (palais mou) :
- A. Lames palatine sont unies mais pas le palais mou
 - B. avec la croissance les lames palatine se rapprochent ensemble avec le palais mou
 - C. avec la croissance les lames palatines, s'écartent mais pas le palais mou
 - D. avec la croissance les lames palatine s'écartent ensemble avec le palais mou
 - E. la croissance n'influence en rien les dimension du défaut
- REP: A
8. * Bosse séro-sanguine :
- A. Lésion fréquente du tissu cellulaire sous-cutané, se résorbe spontanément durant la première semaine de vie
 - B. c'est un hématome sous-périostal, se résorbe spontanément durant la première semaine après la naissance
 - C. c'est une lésion commune du tissu cellulaire sous-cutané, ne se résorbe pas spontanément après la naissance, nécessitant un traitement chirurgical
 - D. nécessite la réalisation d'une incision d'évacuation
 - E. nécessite un traitement antibiotique
- REP: A
9. *Le premier geste de diagnostic dans l'atrésie de l'oesophage est :
- A. La réalisation d'une radiographie avec substance de contraste
 - B. la tentative d'introduction d'une sonde dans l'estomac, s'arrête à 10-12 cm de l'arcade dentaire
 - C. réalisation d'un CT (scanner)
 - D. effectuer une bronchoscopie pour mettre en évidence la fistule oeso-trachéale
 - E. aucune réponse n'est correcte
- REP: B
10. *Fistules et kystes cervicaux latéraux :
- A. Apparaissent à la suite d'imperfections lors du développement un bourgeon frontal
 - B. apparaissent à la suite d'imperfections lors du développement (a mugurilior maxilari) bourgeon maxillaires
 - C. apparaissent à la suite d'imperfections lors du développement des arcs et sillons brachiaux
 - D. toutes les variantes sont correctes
 - E. aucune réponses n'est pas correcte
- REP: C
11. La fistule oeso-trachéale en "H" :
- A. Est la malformation plus fréquente de l'œsophage
 - B. l'œsophage sans être interrompu communique avec la trachée par une fistule latérale
 - C. Est cliniquement reconnu après un symptôme capital, la toux répété durant l'allaitement
 - D. le traitement est exclusivement chirurgical et mène à l'élimination de la fistule
 - E. se ferme spontanément aux premiers mois de la vie
- REP: BCD
12. La sténose hypertrophique du pylore se manifeste cliniquement par :
- A. Vomissement blanc symptômes dominant la maladie
 - B. vomissement bilieux
 - C. péristaltisme gastrique - ondes contractiles visibles dans l'épigastre
 - D. hyper salivation abondante
 - E. palpation de l'olive pylorique dans l'hypochondre droit sous-hépatique pendant l'alimentation de l'enfant ou en décubitus latéral gauche
- REP: ACE
13. Lymphadénite mésentérique :
- A. Cause la plus fréquente de douleurs abdominales chez les nourrissons
 - B. ayant comme substrat anatomo-pathologique l'inflammation des ganglions mésentériques situés dans l'angle iléo-caecal
 - C. ayant comme substrat anatomo-pathologique l'inflammation des ganglions rétropéritonéaux
 - D. l'étiologie est microbienne et virale
 - E. les ganglions impliqués sont hypertrophiés et s'accompagnent d'une réaction liquidienne abondante dans la cavité péritonéale
- REP: BDE

14. Le mégacôlon congénital se manifeste par :
- A. Absence de transit intestinal
 - B. distension abdominale progressive
 - C. boulimie
 - D. vomissement alimentaire au début puis bilieux et ultérieurement fécaloïde
 - E. épisode de diarrhée paradoxale avec émission de selles molles malodorantes
- REP: ABDE
15. Les causes favorisant la production de l'invagination intestinale chez les enfants sont :
- A. Polype intestinal
 - B. diverticule de Meckel
 - C. tumeur intestinale bénigne et maligne
 - D. hernie ombilicale
 - E. parasitose (boule de vers rond)
- REP: ABC
16. Dysplasie luxant coxo-fémoral :
- A. Se produit à l'âge de 1 ans
 - B. et plus fréquente chez les garçons
 - C. survient le plus souvent dans la race noire
 - D. localisation unilatérale gauche est plus fréquente
 - E. transmission héréditaire dans 10 % des cas
- REP: DE
17. Le tableau clinique dans la péritonite primitive comprend :
- A. Début brusque avec douleur abdominale violente péri-ombilicale ou sous-ombilical
 - B. absence de la fièvre
 - C. régurgitation
 - D. pendant la période d'état il n'existe pas de défense musculaire évidente
 - E. fréquemment s'associe l'herpès labial
- REP: ACDE
18. Appendicite aiguë :
- A. Viens le plus fréquemment chez le nouveau-né
 - B. est la plus fréquente cause de douleur abdominale chez l'enfant
 - C. et plus rare chez le nourrisson et le petit enfant mais à cet âge un diagnostic tardive et une péritonite peuvent mener au décès
 - D. le tableau clinique et l'évolution sont différents chez le petit enfant face à l'adulte à cause des moyens locaux et généraux de défense plus réduits
 - E. et plus fréquentes dans le sexe masculin
- REP: CD(E)
19. Les signes cliniques de l'atrésie intestinale sont représentés par:
- A. Vomissement bilieux
 - B. distension abdominale
 - C. absence de transit méconial
 - D. hypersalivation
 - E. diarrhée
- REP : ABC
20. Dans le volvulus intestinal :
- A. Le début brusque en plein état de santé avec pleurs vomissements bilieux et distension abdominale épigastrique rapide et progressive
 - B. très vite la quantité des vomissements change et devient fécaloïde et ayant même un contenu sanguin
 - C. l'émission de sel manque ou quelquefois il existe une émission de selles méléniques
 - D. l'état général se détériore rapidement
 - E. apparaît l'hydrops vésiculaire
- REP : ABCD

21. Pneumothorax :

- A. Présente l'accumulation d'air libre dans la cavité pleurale avec compression du poumon vers le hile
 - B. représente l'accumulation de sang libre dans la cavité pleurale avec compression du poumon vers le hile
 - C. le plus souvent lors des plaies pénétrante
 - D. radiologique - hyper transparence d'un hémithorax
 - E. quand il est rencontré en même temps que l'hémithorax - hémopneumothorax
- REP : ACDE

22. Dans le laparoschisis :

- A. Déficit pariétal para-ombilical droit de 2-3 cm par lequel s'extériorise l'intestin grêle et le côlon
 - B. le cordon ombilical est absent
 - C. l'intestin est mal enroulé dû à l'absence du processus de coalescence et les anses éviscérées sont grises, grosses, adhérentes, oedématisées à cause du contact avec le liquide amniotique et le retour veineux et lymphatique difficile au niveau de l'orifice
 - D. l'intestin est plus court ($\frac{1}{3}$ de la taille normale)
 - E. Rarement associés la prématurité
- REP : ACD

23. Les anomalies urétérales de forme et calibre comprennent :

- A. Urètre rétro-cave
 - B. diverticule urétéral
 - C. urétérocèle
 - D. sténoses congénitales urétérales
 - E. méga uretère congénital
- REP: BDE

24. Volet costal :

- A. Se forme à partir de fractures costales multiples avec apparition d'un segment pariétal indépendant d'un point de vue morphologique et fonctionnel
 - B. est caractérisé par l'apparition de mouvements respiratoires paradoxaux
 - C. ne cause pas d'insuffisance respiratoire
 - D. il peut être nécessaire de réaliser une IOT avec support respiratoire
 - E. le traitement est toujours chirurgical
- REP : ABD

25. Dans l'invagination intestinale, la palpation de l'abdomen peut mettre en évidence :

- A. la fosse iliaque droite est vide (signe Dance) dû à l'invagination du caecum
 - B. hydrops vésiculaire
 - C. la tumeur d'invagination peut se palper le plus souvent au niveau sous-hépatique
 - D. loge rénale droite sensible à la palpation
 - E. l'olive pylorique hypertrophiée
- REP : AC

26. Néphroblastome se manifeste clinique par :

- A. Tumeur avec contact lombaire de dimensions variables, lisse ou bosselée, ferme, légèrement mobile
 - B. douleur vague, quelques fois irradiante vers la cuisse, accompagnée de claudication
 - C. hématurie macroscopique
 - D. hypertension artérielle par compression rénale
 - E. diarrhée profuse
- REP : ABCD

27. Hernie inguinale du sexe féminin :

- A. Les dimensions sont plus petites et la strangulation est très rare
 - B. rarement visible chez les nourrissons
 - C. ne se strangule jamais
 - D. une réduction difficile signifie l'engagement d'un ovaire
 - E. il se guérit spontanément à la puberté
- REP: ABD

28. Myéloméningocèle avec l'aire médullaire ouverte :
- A. présente d'une zone centrale rouge, saignante, avec un orifice central par lequel s'écoule du LCR
 - B. est une formation tumorale lombo-sacrée recouverte de la peau
 - C. présente en périphérie une zone de transition avec la peau fine
 - D. lame vertébrale absente et postérieure le canal médullaire est ouvert
 - E. guérir spontanément dans le premier mois après la naissance
- REP: ACD
29. Les énoncés suivants concernant le traumatisme obstétrical vertébro médullaire sont faux :
- A. Plus souvent C1-C2 lors des naissances crâniennes ou la rotation de la tête est forcée, ou C7-D1, conséquence de la traction inverse lors des naissances pelviennes
 - B. la section médullaire est mortelle
 - C. peut se manifester par un choc spinal avec hypotonie hyporéflexie et détresse respiratoire
 - D. les fractures vertébrales sont faciles à mettre en évidence sur une radiographie
 - E. après l'âge de 4 ans sont plus fréquentes chez le sexe masculin
- REP: DE
30. La sténose hypertrophique du pylore se manifeste radiologiquement (examen du baryum) par :
- A. Canal pylorique large et allongé
 - B. canal pylorique filiforme, allongé
 - C. estomac à faible volume
 - D. estomac dilaté
 - E. la présence de baryum dans l'estomac plus de 4 heures après l'ingestion
- REP : BD
31. Dans la maladie Lobstein :
- A. Les malades sont de petite taille
 - B. les malades ont une taille normale
 - C. les dents sont implantées de façon vicieuse
 - D. la denture n'est pas affectée
 - E. les fractures multiples se produisent après des traumatismes mineurs
- REP: ACE
32. Préopératoire dans la hernie diaphragmatique il est nécessaire :
- A. le positionnement en décubitus latéral du côté sain
 - B. positionnement en décubitus latéral sur la partie affectée
 - C. sonde naso-gastrique
 - D. administration de lait maternel
 - E. intervention chirurgicale par voie abdominale
- REP: BC
33. Lesquels des énoncés suivants au sujet de la hernie inguinale du nouveau-née et du nourrisson sont vrais :
- A. Peut apparaître avec les premiers pleurs, surtout chez les prématurés
 - B. Par augmentation de la pression abdominale le canal s'élargit et permet l'engagement et la progression d'une anse abdominale
 - C. dans la majorité des cas se réduit spontanément sauf dans les moments d'efforts et si elle est volumineuse se maintient aussi pendant le repos descend dans le scrotum
 - D. si elle apparaît après l'effort - hernie incoercible
 - E. à l'occasion de la réduction on apprécie la taille de l'orifice inguinal externe par insertion du petit doigt à partir du scrotum
- REP: ABCE
34. Iléus méconial :
- A. représente une obstruction jéuno-iléales du nouveau-né
 - B. toujours associé à une fibrose kystique du pancréas
 - C. n'est pas associé à la mucoviscidose
 - D. est fréquemment associé à l'atrésie des voies biliaires
 - E. se produit dans l'hypertension portale avec hypersplénisme
- REP: AB

35. traitement des défauts labiaux et palatins :

- A. formes simples de fente labiale s'opèrent à 2-3 mois après la naissance
- B. formes simples de fente labiale s'opèrent à 6-8 mois après la naissance
- C. les cas de fente labiale complète s'opèrent à l'âge de 6 mois
- D. Défauts de palais sont corrigées à l'âge de 18-24 mois
- E. défauts de palais sont corrigés à 6 mois et de la lèvre 18-24 mois

REP : ACD

36. La strangulation de la hernie inguinale se manifeste par :

- A. douleur
- B. vomissements
- C. accélération du transit intestinal
- D. tumeur inguinal sensible à la palpation
- E. aucun signe ci-dessus

REP: ABD

37. Fractures obstétricales crâniennes :

- A. sont fréquentes grâce aux sutures cartilagineuse qui permettent la déformation du crâne
- B. sont le plus souvent des lésions linéaires
- C. sont le plus souvent des lésions avec pénétrations
- D. quelques fois accompagnées d'un céphalématome
- E. fractures avec pénétration plus de 5-6 mm nécessite une correction chirurgicale afin d'éviter tous troubles neurologiques

REP : ABDE

38. Hypospadias :

- A. consiste à ouvrir de l'urètre sur la face dorsal du pénis
- B. consiste à ouvrir l'urètre sur la face ventrale du pénis
- C. est associé avec une coudage peno-glandulaire
- D. est associé avec une coudage péno-scrotale
- E. est associé à l'incontinence urinaire

REP : BDE

39. Hydrocèle :

- A. est une formation kystique contenant de liquide clair, situé dans un reste de canal péritonéovaginal
- B. apparaît par une dilatation des veines spermatiques
- C. c'est causé par l'accumulation de sang dans la vaginale testiculaire
- D. peut disparaître spontanément jusqu'à l'âge de 1 an
- E. est non douloureuse à la palpation

REP: ADE

40. Dans la sténose anale :

- A. orifice anal est normalement situé
- B. orifice anal est ectopique
- C. canal anal obturé incomplètement par un diaphragme muqueux
- D. canal obturé complètement par un diaphragme muqueux
- E. selle avec aspect de crayon

REP: ACE

41. traumatismes obstétricaux de la peau et du tissus sous-cutané :

- A. sont les plus fréquents et les moins graves traumatismes obstétricaux
- B. sont rares et les moins graves traumatismes obstétricaux
- C. apparaissent surtout au niveau de certaines proéminences (oreilles, nez, yeux, extrémités, organes génitaux) surtout après les manoeuvres obstétricales
- D. représentent souvent des portes d'entrée pour les infections (ostéomyélite, gangrène cutanée extensive, furonculose)
- E. ils guérissent toujours avec les séquelles

REP: ACD

42. Les lésions malformatives résultant d'une résorption incomplète ou de la persistance du canal omphalo-entérique comprend :
- A. fistule ombilicale aveugle
 - B. diverticule de merckel
 - C. persistance du canal peritoneo-vaginal
 - D. le diverticulum oesophagien
 - E. fistule ombilicale de l'ouraque
- REP: ABE
43. Les malformations possibles associées aux malformations duodénales sont :
- A. mongolisme dans 30% des cas
 - B. malformations cardiaques
 - C. malformations veineuse
 - D. malformations de l'intestin grêle
 - E. prématurité
- REP: ABDE
44. saignement (hémorragie) par diverticule iléal de meckel :
- A. Se produit par ulcération de la muqueuse iléale adjacente aux îlots de muqueuse gastrique sécrétante
 - B. les saignements ne sont pas douloureux
 - C. dans les petits saignements répétés se modifie la couleur des selles sans en modifier la consistance
 - D. dans les saignements abondants et répétés se modifie autant la couleur que la consistance des selles et survient des signes de choc hypovolémique
 - E. est accompagné par coliques abdominales
- REP: ABCD
45. Fistule ombilicale aveugle :
- A. Représente la persistance de la portion externe du conduit omphalo-entérique
 - B. Est tapissé de muqueuse digestive sécrétoire produisant une sécrétion séreuse
 - C. l'exploration se fait avec une sonde boutonnée ou par radiographie avec substance de contraste de profil
 - D. le traitement est chirurgical consiste en l'excision de la fistule sans ouverture du péritoine exception faite des cas dans lesquels la fistule se continue par un cordon fibreux vers l'iléon et le mésentère
 - E. ne nécessite pas de traitement chirurgical
- REP: ABCD
46. Hernie hiatale :
- A. est produit par foramen Morgani
 - B. est produit par foramen Bochdalek
 - C. est produit par hiatus oesophagiens
 - D. en association avec SHP - syndrome Roviralta
 - E. est produit par foramen ovale
- REP: CD
47. Les déclarations suivantes sur l'hygrome sont fausses :
- A. est continuité de multiples formations kystiques de différentes dimensions, disposées de façon anarchique et séparées entre elles par des septums endothéliaux
 - B. envahit les muscles et adhère aux vaisseaux et aux nerfs
 - C. n'envahit pas le muscle et n'adhère pas aux vaisseaux et aux nerfs
 - D. localisé le plus souvent dans la zone latéro-cervicale ou axillaire
 - E. localisé le plus souvent dans la zone palmaire ou plantaire
- REP: CE

48. Cliniquement dans la hernie diaphragmatique congénitale nous rencontrons :
- A. la respiration polypnéique
 - B. a la percussion, sonorité pulmonaire physiologique
 - C. a la percussion sonorité pulmonaire remplacée par la matité
 - D. a l'auscultation: silence respiratoire, les bruits du péristaltisme sont percevable dans le thorax
 - E. les bruits cardiaques s'entendent du côté droit
- REP: ADE
49. Dans l'atrésie de l'oesophage on rencontre les symptômes suivants :
- A. impossibilité de déglutition
 - B. troubles respiratoires
 - C. hypersalivation et stagnation bucco-pharyngée des sécrétions
 - D. la crise de toux et la cyanose
 - E. polydipsie
- REP: ABCD
50. Traitement chirurgical des fistules et des kystes cervicaux latéraux branchiogéniques :
- A. Suppose l'extirpation de tout le trajet fistuleux
 - B. se fait en pleine poussée inflammatoire
 - C. pour des raisons d'esthétique on pratique incisions transversales étagées
 - D. se fait après résolution de la poussée inflammatoire
 - E. pour des raisons d'esthétique on pratique incisions vertical étagées
- REP: ACD

QCM Chirurgie pédiatrique - 2020

1. *La forme anatomo-pathologique d'hydrocèle qui peut guérir spontanément est :
 - A. Hydrocèle vaginale
 - B. kyste du cordon
 - C. hydrocèle communicant
 - D. toutes les formes énumérées
 - E. kyste du canal de NuckREP: A
2. *La cause la plus fréquente d'hydronéphrose congénitale est:
 - A. un rein en fer de cheval
 - B. vaisseaux polaires inférieurs
 - C. haut insertion de l'uretère
 - D. sténose de jonction pyélo-urétérale
 - E. rein ectopiqueREP: A
3. *Dans la hernie hiatale l'angle de Hiss (forme par le fornix gastrique et l'oesophage) :
 - A. est exactement à 90 degré
 - B. ne change pas de la normale
 - C. est inférieure à 90 degré
 - D. c'est obtus, essuye ou disparaît
 - E. aucune réponse n'est correcteREP: C
4. *Dans le mégacôlon congénital :
 - A. jéjunale
 - B. anale
 - C. recto-sigmoïde
 - D. iléale
 - E. caecaleREP: C
5. *Dans l'atrésie duodénale le symptôme dominant est représenté par :
 - A. vomissements méconiaux
 - B. l'abdomen météorise
 - C. vomissements bilieux - apparaît dans 90% des cas dans les premières 24 heures
 - D. vomissements blancs
 - E. selles diarrhéiquesREP: C
6. *Les invaginations plus fréquentes sont :
 - A. iléo-caeco-colique
 - B. ano-rectale
 - C. duodéno-jéjunale
 - D. jéjuno-iléale
 - E. gastro-duodénaleREP: A
7. *Dans la lymphadénite mésentérique :
 - A. dans l'épigastre
 - B. dans la fosse iliaque gauche
 - C. dans la fosse iliaque droite
 - D. périombilicale
 - E. dans l'hypogastreREP: D

8. *Dans la malrotation intestinale avec volvulus la radiographie avec solution de contraste indique :
- A. l'image en "tire-bouchon"
 - B. la présence de la substance de contraste au-dessus et au-dessous de l'anse volvulée
 - C. l'image en balance
 - D. opacification de toute le cadre colique
 - E. rétention de la substance de contraste dans l'anse volvulée
- REP: A
9. Les hémangiomes :
- A. Sont des tumeurs vasculaire composée de capillaire de néo-formation de type malin
 - B. ils peuvent être localisé dans toutes les parties du corps
 - C. ils sont de différentes tailles
 - D. sont des tumeurs vasculaire composé de capillaire de néo-formations de type Bénin
 - E. le sexe féminin est plus fréquemment affecté
- REP: BCDE
10. Hygromas :
- A. Et une formation tumorale de la peau
 - B. dans les poussées inflammatoires les troubles respiratoires s'aggrave
 - C. est constitué de multiples formation kystique localiser dans la zone cervicale
 - D. son prolongement médiastinale s'accompagne de dyspnée
 - E. disparaissent spontanément à la puberté
- REP: BCD
11. le tableau clinique de la fracture obstétricale de la clavicule :
- A. La fracture obstétricale de la clavicule survient dans les premiers jours après la naissance
 - B. l'examen clinique peut révéler un callus hypertrophique détectable à la palpation
 - C. le nouveau-né avec une fracture de la clavicule est agitée et cri à la mobilisation du membre du côté de la lésion
 - D. Est dominé par l'impotence fonctionnelle totale du membre du côté affecté
 - E. la fracture obstétricale de la clavicule se produit spontanément où est provoqué intentionnellement pour la libération d'une épaule dystocique à la naissance
- REP: BCE
12. Les complications des hémangiomes sont :
- A. L'ulcération
 - B. L'hémorragie
 - C. L'infection
 - D. le syndrome de Kassabach-Merritt
 - E. le syndrome de Klippel-Trenaunay
- REP: ABCD
13. Dans l'imperforation anale membraneuse :
- A. L'orifice anale et ectopique
 - B. l'orifice anal normalement situé est obturé par une membrane fine qui se bombe sous la pression du méconium
 - C. Selle avec aspect de crayons
 - D. une simple incision en croix permet l'évacuation du méconium
 - E. l'orifice anale est obturé incomplètement par un diaphragme muqueux
- REP: BD
14. Invagination intestinale :
- A. C'est plus fréquent chez les nourrissons
 - B. détermine une occlusion intestinale mécanique
 - C. représente la pénétration d'un segment intestinale par une fente du mésentère
 - D. c'est plus fréquent chez le nouveau-né
 - E. représente le télescopage de l'anse intestinale supra jacente dans l'anse sous-jacente
- REP: ABE

15. Hernie inguinale :
- A. Peut produire une nécrose testiculaire par compression sur le cordon spermatique
 - B. est plus fréquent chez les femelles
 - C. l'étranglement est la complication la plus courante
 - D. doit être opérée à la naissance
 - E. peut disparaître dans la première année
- REP: ACE
16. Hernie Diaphragmatique congénitale :
- A. Les formes tolérées peut-être diagnostiquées chez l'enfant plus âgé
 - B. c'est plus fréquents du côté droit
 - C. en l'absence de diagnostic précoce dans 70 % des cas de HD, le décès survient dans les 24-48 heures de vie
 - D. Présumer l'existence d'un défaut dans le diaphragme avec une hernie pulmonaire dans l'abdomen
 - E. présumer l'existence d'un défaut dans le diaphragme avec une hernie des viscères abdominaux dans le thorax
- REP: ACE
17. Le diagnostic de hernie inguinale est établi par :
- A. IRM de l'abdomen
 - B. La formation d'une tumeur herniaire est visible la réduction est pratiquée en taxis
 - C. examen clinique de la région de l'aîne
 - D. palpation pendant l'effort de toux
 - E. radiographie
- REP: BCD
18. Le diagnostic différentiel de la fracture obstétricale de la clavicule se fait avec :
- A. Fracture obstétricale du fémur
 - B. ostéo arthrite septique périnatale
 - C. paralysie du plexus brachial
 - D. fracture obstétricale de l'humérus
 - E. insuffisance motrices d'origine centrale
- REP: CDE
19. Hydrocel :
- A. C' est causée par l'accumulation de sang dans la vaginale testiculaire
 - B. Est une formation kystique contenant du liquide clair si tu es dans un reste de canal péritonéo vaginale
 - C. apparaît par une dilatation des veines spermatique
 - D. Est non douloureuse à la palpation
 - E. peut disparaître spontanément jusqu'à l'âge de 1 ans
- REP: BDE
20. Reflux vésico-urétéral (VUR) :
- A. Le patient peut présenter des signes d'infection urinaire : pollakiurie, hématurie, pyurie
 - B. est causée par une obstruction dans la voie d'évacuation de l'urine du niveau urétéral supérieur
 - C. peut-être causé par une perturbation du mécanisme physiologique de la jonction urétéro vésicale
 - D. est fréquemment associée à des signes d'infection respiratoire aiguë
 - E. Les cas graves peuvent présenter des manifestations d'insuffisance rénale chronique
- REP: ACE
21. L'évolution des hémangiomes :
- A. Sous des formes étendue en 3-4 mois peut envahir des zones considérables
 - B. la plupart croissent rapidement après l'âge d'un an
 - C. ils peuvent disparaître en quelques mois ou jusqu'à 5-6 ans
 - D. la plupart grandissent proportionnellement à l'enfant
 - E. c'est prévisible
- REP: ACD

22. Cliniquement dans l'appendicite aiguë nous rencontrons :
- A. Douleur localisée péri-ombilical
 - B. myalgie gastrocnémienne
 - C. douleur dans la fosse iliaque droite
 - D. la douleur peut s'atténuer spontanément en face d'appendicite gangréneuse et réapparaître de façon brusque au moment de la perforation
 - E. vomissement unique ou répéter apparaît surtout au début de l'affection dans plus de 90 % des cas
- REP: CDE
23. Le traitement de la fracture obstétricale de la clavicule implique :
- A. Réduction fermée par une traction douce
 - B. bandage doux de type Dassault pendant 14 jours
 - C. immobilisation plâtrée du membre atteint en position de "salut militaire"
 - D. l'immobilisation plâtrée de type Dassault pendant 4 semaines
 - E. les fractures obstétricales qui, au moment du diagnostic, présente le cal osseux ne nécessite plus de traitement orthopédique
- REP: CE
24. Les déclarations suivantes concernant les hypospadias sont fausses :
- A. Dans les hypospadias penoscrotales et scrotales, les testicules sont généralement situées dans les bourses scrotales homolatérales
 - B. le traitement de l'hypospadias est organisé en fonction de la forme anatomo pathologique et de l'âge de l'enfant
 - C. l'hypospadias périnéale est la forme la plus facile à traiter
 - D. dans les hypospadias balaniques, le flux urinaire est normal
 - E. dans les hypospadias, l'urétroplastie est réalisée après une seule intervention vers l'âge de 2 ans
- REP: CDE
25. Les déclarations suivantes concernant les hypospadias sont vraies :
- A. L'hypospadias est causée par la résorption de la lame urétrale du tubercule génital et par le d'union des plis génitaux (dysraphisme) dans le sinus urogénital
 - B. l'hypospadias balanique est la forme la plus bénigne et la plus fréquente
 - C. dans les hypospadias, il existe différents degrés de torsion latérale du pénis
 - D. l'hypospadias est l'ouverture de l'urètre dans le pénis dorsal
 - E. Dans les hypospadias penoscrotales et scrotales, le méat urinaire s'ouvre au niveau du périnée antérieure sur la ligne ano-scrotale
- REP: ABC
26. Le traitement préopératoire dans l'omphalocèle comprend :
- A. radiographie thoracique, ECG, analyses de laboratoire
 - B. positionnement le nouveau-né en décubitus ventral
 - C. protections de l'omphalocèle avec des compresses imbibées dans un sérum physiologique chaud
 - D. sonde naso-gastrique et rectale pour prévenir la distension du tube digestif
 - E. une naissance par césarienne si le diagnostic prénatal est connu
- REP : ACDE
27. Les déclarations suivantes concernant les hypospadias sont vraies :
- A. L'urétropropastie est réalisée après une seule procédure à l'âge de 6-7 ans
 - B. Les objectifs du traitement de l'hypospadias visent à retrouver la forme du pénis et a réaliser un néo-urètre afin d'obtenir des mictions physiologiques des érections et des éjaculations
 - C. la correction des vices morphologiques du pénis a lieu vers l'âge de 2 ans
 - D. le recalibrage du méat hypospadiques sténotique se fait à l'adolescence
 - E. il est conseillé de terminer le traitement jusqu'à l'âge de la scolarité afin de diminuer les complexes mentaux de ces enfants qui peuvent être accentuées une fois entrée dans la communauté
- REP: BCE

28. Les symptômes présents dans la hernie inguinale étranglée sont :
- A. douleur
 - B. selles diarrhéiques et hémorragiques
 - C. vomissements
 - D. tumeurs inguinales
 - E. hématomène
- REP: ABCD
29. Le reflux vésico-urétéral peut être causé par :
- A. contraction intra-vésicale de l'uretère
 - B. syndrome de Prune-Belly
 - C. Dissidence de Marion (hypertrophie du col vésical)
 - D. Raccourcir une/ou une immaturité de l'uretère intravésical
 - E. Valvules urétrales postérieures
- REP: BCDE
30. Traitement de la hernie inguinale :
- A. est principalement médical
 - B. ne nécessite pas de procédures pour renforcer la paroi abdominale
 - C. est chirurgical
 - D. chez les filles, l'ancrage du pilier péritonéal au tendon conjonctif est pratique (procédure Barker)
 - E. peut être atteint à tout âge
- REP: CDE
31. Les formes anatomopathologiques des hémangiomes sont :
- A. hémangiomatose diffuse
 - B. hémangiome intradermique ou plan "tache de vin"
 - C. hémangiome caverneux
 - D. malformation artério-veineuse
 - E. hémangiome tubereuse
- REP: ABCE
32. saignement (hémorragie) par diverticule iléal de Meckel :
- A. est accompagné par coliques abdominales
 - B. dans les petits saignements répétés se modifie la couleur des selles sans en modifier la consistance
 - C. se produit par ulcération de la muqueuse iléale adjacente aux îlots de muqueuse gastrique sécrétante
 - D. dans les saignements abondants et répétés se modifie autant la couleur que la consistance des selles et survient des signes de choc hypovolémique
 - E. le saignement est sans douleur
- REP: BCDE
33. L'évolution d'un patient souffrant de reflux vésico-urétéral peut avoir lequel de ces scénarios :
- A. les infections urinaires n'apparaissent pas de manière unilatérale
 - B. le reflux de bas grade chez le nouveau-né peut évoluer avec une rémission spontanée
 - C. l'atrophie rénale est secondaire à la haute pression de reflux exercée sur le parenchyme rénal
 - D. les infections urinaires peuvent être récurrentes
 - E. le reflux bilatéral ne provoque pas d'insuffisance rénale chronique
- REP: CD
34. Parmi les examens d'imagerie utilisés dans la fracture obstétricale de la clavicule
- A. tous les nouveau-nés d'un accouchement difficile bénéficient d'une radiographie thoracique parce que la plupart présente habituellement une fracture obstétricale
 - B. si la fracture est détectée tardivement, la radiographie révèle un callus hypertrophique
 - C. la radiographie révèle souvent une fracture en bois vert
 - D. IRM est souvent utilisée pour détecter une fracture de la clavicule chez le nouveau-né car il est non invasif
 - E. la radiographie n'est pas utile dans le diagnostic à cet âge parce que la clavicule n'est pas ossifiée chez 50% des nouveau-nés à la naissance
- REP: BC

35. Le mégacôlon congénital se manifeste par :

- A. Absence de transit intestinal
- B. distension abdominale progressive
- C. boulimie
- D. vomissement alimentaire au début puis bilieux et ultérieurement fécaloïde
- E. épisode de diarrhée paradoxale avec émission de selles molles malodorantes

REP: ABDE

36. Traumatismes obstétricaux :

- A. sont causées par une disproportion entre les dimensions du fœtus et la filière plus étroite du bassin maternelle
- B. aucune réponse n'est pas correcte
- C. sont causés par la position fœtale anormale
- D. sont plus fréquentes à la première naissance
- E. ils n'ont jamais un risque vital

REP: ACD

37. Traitement des défauts labiaux et palatins

- A. défauts de palais sont corrigés à l'âge de 18-24 mois
- B. défauts de palais sont corrigés à 6 mois et de la lèvre 18-24 mois
- C. formes simples de fente labiale s'opèrent à 6-8 mois après la naissance
- D. les cas de fente labiale complète s'opèrent à l'âge de 6 mois
- E. formes simples de fente labiale s'opèrent à 2-3 mois après la naissance

REP: ADE

38. Le diagnostic différentiel de la hernie inguinale se fait avec :

- A. cryptorchidie ou testicules ectopiques
- B. formation des tumeurs abdominales
- C. kyste du cordon Nuck (la petite fille)
- D. hydrocèle vaginale
- E. appendicite aiguë

REP: ACD

39. Traitement du kyste du canal thyroïdienne :

- A. consiste en la résection du tout le trajet fistuleux jusqu'à la base de la langue
- B. comporte la résection de la partie centrale d'os hyoïde
- C. est chirurgical et se pratique après l'arrêt du processus inflammatoire
- D. est chirurgical et se pratique au cours du processus inflammatoire
- E. il est strictement médical

REP: ABC